



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SRUWENG
DENGAN
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GOMBONG**

Nomor : 150/SP/PKU.S/V/2026

Nomor : 229/PKS/IV.6.AU/A/V/2026

**TENTANG
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG**

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (18-05-2026), bertempat di Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **dr. H. Hasan Bayuni**, selaku Direktur Utama, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kebumen Nomor 68/KEP/III.0/D/2024 tanggal 01 April 2024 tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit (RS) PKU Muhammadiyah Sruweng Periode 2023 - 2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili RS PKU Muhammadiyah Sruweng, yang berkedudukan di Jalan Raya Sruweng No : 5 Kebumen, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. (Cand) dr. Anita Widi Hastuti, Sp. THT – BKL, M.H, MARS** selaku Direktur Utama, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah nomor: 135/KEP/II.0/D/2026 tanggal 01 April 2026 tentang Pengangkatan Direktur Utama RS PKU Muhammadiyah Gombong Masa Jabatan 2026 - 2029, yang berkedudukan Jl. Yos Sudarso No. 461 Gombong - Kebumen, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama sama **PARA PIHAK** dan untuk masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

a	f t
---	-----



1. Bahwa **PARA PIHAK** adalah rumah sakit memiliki usaha yang sama, yaitu bergerak dalam bidang jasa pelayanan medis/Kesehatan bagi Masyarakat secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
2. Bahwa **PARA PIHAK** adalah merupakan institusi yang berbeda dan masing-masing pihak saling mengakui dan menjaga Batasan kewenangan serta bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku di Lingkungan Kesehatan, maupun institusi masing-masing pihak;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian Kerjasama dalam hal pelayanan tindakan rujukan pasien dengan memelihara itikad baik yang semestinya;
4. Pihak pengirim rujukan adalah Pihak yang merujuk pelayanan Kesehatan pasien kepada pihak penerima rujukan;
5. Pihak Penerima Rujukan adalah pihak yang menerima rujukan pasien dari Pihak Pengirim Rujukan
6. Pasien adalah pasien yang dirujuk pihak pengirim rujukan kepada pihak penerima rujukan untuk mendapatkan pemeriksaan penunjang atau Tindakan medis sesuai surat rujukan dan/ atau surat pengantar.
7. Surat rujukan adalah surat yang dibuat oleh dokter yang berisi pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan Kesehatan secara timbal balik, baik secara vertical maupun horizontal.
8. Rujukan Pelayanan Kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab Kesehatan secara timbal balik baik vertical maupun horizontal;
9. Dalam rangka memberikan pelayanan Kesehatan yang optimal kepada Masyarakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam pelaksanaan Kerjasama pelayanan rujukan Kesehatan yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya di sebut “ Perjanjian “ dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :



BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- 1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelayanan rujukan Kesehatan terhadap pasien **PIHAK KESATU** untuk mendapatkan pelayanan rawat inap dan atau pemeriksaan penunjang yang belum dimiliki oleh **PIHAK KESATU**.
- 2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Insentif, Pelayanan Gawat Darurat, Rawat Inap, Rujukan Tindakan Spesialis, dan Pelayanan Penunjang yang tidak dapat dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.

BAB III PROSEDUR RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN Pasal 3

- 1) **PIHAK KESATU** akan merujuk pasien apabila :
 - a. Pasien membutuhkan pelayanan Kesehatan spesialistik atau sub spesialistik;
 - b. Tidak dapat memberikan pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, penunjang dan fasilitas Kesehatan dan / atau ketenagaan.



- 2) **PIHAK KEDUA** akan merujuk Kembali pasien ke Rumah Sakit milik **PIHAK KESATU** apabila :
 - a. Permasalahan Kesehatan pasien dapat ditangani oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sebagai tempat pelayanan Kesehatan.
 - b. Kompetensi dan kewenangan **PIHAK KESATU** akan lebih baik dalam menangani pasien tersebut.
 - c. Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh **PIHAK KESATU** akan lebih baik dalam menangani pasien tersebut.
 - d. Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh **PIHAK KESATU** sebagai tempat pelayanan Kesehatan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka Panjang dan/ atau
 - e. **PIHAK KEDUA** tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan
- 3) **PIHAK KESATU** harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/ atau keluarga pasien setelah diberi penjelasan dari tenaga Kesehatan yang berwenang.
- 4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi :
 - a. Diagnosis dan terapi dan/ atau Tindakan medis yang diperlukan
 - b. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan
 - c. Risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan
 - d. Transportasi rujukan
 - e. Risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan



Pasal 4

- 1) **PIHAK KESATU** sebelum merujuk terlebih dahulu melakukan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan pertolongan pertama dan atau Tindakan stabilisasi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan.
 - b. Melakukan komunikasi awal dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam keadaan pasien gawat darurat dengan mengisi aplikasi SISROUTE dan komunikasi via telpon ke IGD RS PKU Muhammadiyah gombong
 - c. Membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan yang paling sedikit memuat :
 1. Identitas pasien
 2. Hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan.
 3. Terapi dan/ atau Tindakan yang diberikan
 4. Tujuan rujukan
 5. Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan
 6. Nama dan tanda tangan tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan dan status pembiayaan pasien
 - d. Surat pengantaran rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat oleh tenaga medis, dikecualikan pada keadaan gawat darurat maka surat pengantar rujukan dapat dilakukan oleh bidan/ perawat.
- 2) Komunikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah **PIHAK KESATU** menghubungi **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan informasi mengenai ketersediaan sarana prasarana kompetensi, dan tenaga Kesehatan.
- 3) Pelayanan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** akan dilayani selama 24 jam
- 4) Pendaftaran pasien dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berdasar pada surat rujukan yang dibawa oleh **PIHAK KESATU**.
- 5) Dalam hal membutuhkan laporan medis, maka **PARA PIHAK** menjamin telah memiliki otorisasi dari pasien dan bertanggungjawab terhadap segala resiko yang timbul dari penyerahan laporan medis tersebut.



- 6) Jika dalam kategori emergensi atau gawat darurat yang dilayani di IGD, untuk rujukan tertuju poliklinik maka sesuai dengan jam praktek poliklinik terkait.

Pasal 5

- 1) **PIHAK KESATU** pada saat mengirim rujukan ke **PIHAK KEDUA** pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulance dan di dampingi oleh tenaga yang berkompeten
- 2) Dalam hal tidak tersedia ambulance pada fasilitas pelayanan Kesehatan perujuk, maka rujukan dapat dilakukan dengan alat transportasi lain yang layak.
- 3) Petugas medis/ paramedis yang mendampingi rujukan pasien harus menunjukkan identitas yang jelas bahwa yang bersangkutan adalah tenaga Kesehatan.
- 4) Penempatan pasien **PIHAK KESATU** yang memerlukan pelayanan rujukan Kesehatan disesuaikan dengan kelas perawatan yang diminta oleh pihak keluarga yang bertanggungjawab.



BAB IV
PEMBIAYAAN DAN PENDAFTARAN
Pasal 6

- 1) Biaya pelayanan Kesehatan pasien berupa pemeriksaan penunjang yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** menjadi tanggungjawab pihak kesatu, sedangkan untuk pelayanan Kesehatan rawat inap menjadi tanggungjawab pasien.
- 2) Tarif pelayanan ditentukan berdasarkan daftar tarif yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang – undangan.
- 3) Pembayaran biaya pelayanan akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** setiap satu bulan sekali pada bulan berikutnya setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan invoice untuk dilakukan pembayaran oleh **PIHAK KESATU**.
- 4) Apabila terdapat perubahan tarif pelayanan, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perubahan tarif diberlakukan.
- 5) Pembayaran dilakukan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara pemindahbukuan melalui rekening **PIHAK KEDUA**:

Atas Nama Rekening : RS PKU Muhammadiyah Gombong
Nomor Rekening : 01.34-01-000154-30-3
Bank : Bank Rakyat Indonesia

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 7

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan lanjutan bagi pasien rujukan **PIHAK KESATU** secara lebih lengkap, bermutu dan profesional dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memperoleh informasi, penjelasan dan data yang diperlukan sebagai dasar untuk perbaikan mutu pelayanan kesehatan selama proses rujukan berlangsung; dan
 - c. Menerima umpan balik hasil rujukan dari **PIHAK KEDUA**.



- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan informasi dan data mengenai keadaan pasien yang dirujuk **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Menerima pembayaran atas pelayanan yang telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. Melakukan prosedur rujukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
 - b. Menaati tata tertib dan ketentuan pelayanan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melakukan pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 - a. Menerima rujukan dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan Standar Prosedur Operasional;
 - b. Memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan secara lengkap, bermutu dan profesional sesuai Standar Prosedur Operasional ;
 - c. Menyediakan Layanan Informasi melalui telepon untuk pelayanan kegawatdaruratan dengan operator penerima telepon yang mengetahui:
 1. terminologi di Rumah Sakit;
 2. jenis dan tarif pelayanan;
 3. tenaga jaga/on duty (dokter, perawat/bidan dan tenaga penunjang); dan
 4. Sarana prasarana yang tersedia.
 - d. Memberikan informasi dan edukasi terkait tarif dan pembiayaan;
 - e. Memberikan umpan balik terhadap kasus yang dirujuk secara tertulis dan dikirim kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - f. Mengirimkan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi apabila diperlukan.

BAB VI
INDIKATOR MUTU PELAYANAN
DAN EVALUASI
Pasal 8

- 1) PARA **PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- 2) Indikator mutu pelayanan yang digunakan dalam evaluasi meliputi :
 - a. Kepatuhan identifikasi pasien sebesar 100%;
 - b. Kelengkapan dokumen rujukan pasien $\geq 95\%$;

- c. Ketepatan komunikasi dan serah terima informasi pasien rujukan $\geq 85\%$;
 - d. Pelaporan dan tindak lanjut insiden keselamatan pasien sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan rujukan $\geq 85\%$.
- 3) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan mutu dan peningkatan keselamatan pasien secara berkesinambungan.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pengukuran dan tindak lanjut hasil evaluasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII JANGKA WAKTU Pasal 9

- 1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 20 Mei 2026 sampai dengan 21 Mei 2029. dan akan dievaluasi setiap semester berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- 3) Apabila salah satu PIHAK hendak memperpanjang Perjanjian ini, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian ini harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada PIHAK lain dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

BAB VIII KERAHASIAAN MEDIS Pasal 10

PARA PIHAK selama pelaksanaan Perjanjian ini maupun setelah selesainya Perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas pasien dan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 11

- 1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah berakhir jangka waktunya dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan memperpanjang jangka waktu; dan/atau
 - b. adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini oleh salah satu Pihak apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Pihak lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan.
- 2) Pengakhiran Perjanjian tidak serta merta menghapus kewajiban masing-masing PIHAK yang belum terlaksana sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian.
- 3) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, masing-masing PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan adanya putusan pengadilan dalam pengakhiran suatu perjanjian.

BAB X
FORCE MAJEURE
Pasal 12

- 1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa yang dimaksud dengan Force Majeure adalah hal-hal yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya yang mengakibatkan tertundanya pekerjaan di luar kemampuan **PARA PIHAK**, terkecuali kebakaran yang disebabkan oleh kesengajaan salah satu PIHAK.
- 2) PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis, paling lambat 1 (satu) bulan kalender saat terjadi peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa tersebut.
- 3) Masing-masing PIHAK tidak akan menuntut PIHAK lain atas tertundanya pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh Force Majeure.

g.	f f
----	-----



BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

- 1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan, maka akan dilakukan penyelesaian dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Kebumen.

BAB XII
ALAMAT KORESPONDENSI
Pasal 14

Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lainnya dalam Perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan, apabila terdapat tanda penerimaan yang sah dari PIHAK yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : RS PKU MUHAMMADIYAH SRUWENG

Alamat : Jalan Raya Sruweng No. 05 Sruweng Kebumen
Email : pkumuhsruweng@gmail.com
PIC Kerjasama : Tri Dina Lestari, S, Kep. Ns
No Hp : 081327667333

PIHAK KEDUA : RS PKU MUHAMMADIYAH GOMBONG

Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 461 Gombong
Email : rspkumuhammadiyahgb@gmail.com
PIC Kerjasama : Restutusi Ayu Waluyo, A.Md. KL
No Hp :

Q.	f f
----	-----



BAB XIII
ADDENDUM
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu buah untuk **PIHAK KESATU** dan satu buah lagi untuk **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU
RS PKU MUHAMMADIYAH SRUWENG

PIHAK KEDUA
RS PKU MUHAMMADIYAH GOMBONG



Dr. H. HASAN BAYUNI
Direktur Utama



Dr. (Cand) dr. ANITA WIDI HASTUTI,
Sp.THT - BKL, M.H, MARS
Direktur Utama